Diskussion 99

Datum: 1908-05-16
Kammare: Första kammaren
Antal yttranden: 3
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus (doi:10.5281/zenodo.18211787), byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).

Markerade ord: ¹ kvinna-ord, ² släktskaps- och tilltalsord, ³ yrkestitlar.

1. Julius Juhlin (–, man)

Herr talman, mina herrar! Jag har icke något yrkande att göra, utan instämmer i utskottets hemställan, som jag finner synnerligen behjärtansvärd. Det är emellertid ett yttrande, som utskottet haft på sidan 42, hvilket jag skulle särskildt vilja stryka under. Då jag anser detta uttalande af så stor vikt, tillåter jag mig att med herr vice talmannens tillstånd uppläsa det.

I sista stycket på sidan 42 skrifver utskottet:

»Det har visserligen yppat sig någon tvekan, huruvida vårt land skulle äga tillräckligt många för tuberkulossjukhusvården särskildt skolade läkare för att möta det behof af sådana, som anordnandet af ett stort antal tuberkulosvårdanstalter skulle medföra. I anledning häraf tillåter sig utskottet meddela, att, enligt hvad utskottet inhämtat, svenska nationalföreningen mot tuberkulos sedan år 1904 till läkare utdelat stipendier, i regel 6 om året, för studier af sådan vård vid jubileumsfondens sanatorier, och att föreningen lärer hafva för afsikt att äfven framdeles fortsätta härmed. Det kan bär tilläggas, att föreningen nyligen beslutat utdela stipendier jämväl åt **sjuksköterskor³** för idkande af studier vid tuberkulossjukvårdsanstalter. Utskottet finner dock denna fråga vara af den vikt, att ett särskildt uttalande bör göras därom, att intet bör försummas, som kan göra våra läkare fullt förtrogna med de moderna metoderna för upptäckande och behandling af tuberkulos.»

Här skulle jag vilja sticka in ett litet ord: för upptäckande ? tid af tuberkulos. Jag vill härmed icke klandra våra högskolor, ty de göra allt hvad de kunna för att utbilda skickliga läkare. Jag klandrar icke heller vår skickliga svenska läkarkår, men vågar ändock göra det uttalandet, att våra läkare i regel icke äro nog skolade för att ställa diagnosen på denna förhärjande sjukdom, lungtuberkulosen, på ett tillräckligt tidigt stadium. Vid våra sanatorier är en stor del af patienterna snarare asylpatienter än sanatoriepatienter. Om herrarna i likhet med mig finge genomgå handlingarna vid ett af dessa sanatorier, skulle herrarna komma till samma resultat, nämligen att

våra läkare icke äro skolade för att på tillräckligt tidigt stadium Angående stilla diagnosen, och att man därför kan befara, att dessa sjukvårdsjämna Rs s ss stämmelser anstalter, som väl att börja med, tror jag, komma att blifva ett slags "för åtnjuagsyler, äfven i en lång framtid komma att förblifva det i stället för "tande af att vara sanatorier. statsbidrag Nu har nationalföreningen mot tuberkulos, såsom jag nyss läste (ul Huber: upp, vidtagit en

synnerligen prisvärd handling, då den till dessa folkvärde sanatorier skickat läkare, för att dessa där skola utbildas i lunganstalter. tuberkulosens diagnostik och hygien. Vi hafva ju i vårt land ett = (Forts.) ofantligt stort antal läkare, provinsialläkare och stadsläkare. Det är dessa våra läkare, som i första hand skola hjälpa oss i striden mot den förhärjande sjukdomen. Ett medel i deras hand komma dessa tuberkulossjukvårdsanstalter att blifva, men det är alldeles nödvändigt, att läkarne i tid upptäcka sjukdomen och därigenom rädda det unga, uppväxande släktet från att få föras till asyler. Jag skulle därför vilja rikta en varm vädjan till regeringen att försöka vidtaga några åtgärder i den riktning, som utskottet här har angifvit. Regeringen skulle möjligen kunna gå samma väg, som nationalföreningen mot tuberkulos har gått, nämligen att lämna läkarne stipendier och uppmuntra dem till att vid sanatorier göra sig fullt kompetenta att ställa diagnos på tidig lungtuberkulos. Jag menar, att detta antal af sex om året, som nationalföreningen skickar till sanatorierna, är långt ifrån tillräckligt. Jag förstår mycket väl, att nationalföreningen, som ju har begränsade tillgångar, icke kan skicka flera, men jag tror, att det vore synnerligen önskvärdt, om ett mycket större antal läkare kunde årligen skickas till dessa sanatorier.

2. Carl Nyström (Första kammarens protektionistiska parti, man)

Jag undrar från hvilket håll den senaste talaren har fått den föreställningen, att icke här i Sverige allt göres för att i tid upptäcka tuberkulosen och således också i väsentlig mån öka utsikterna till tillfrisknande. Jag vågar påstå, att de svenska läkarne icke behöfva någon särskild anmaning från Riksdagen att göra sin plikt och följa med sin tid samt prestera det bästa, som samtiden må kunna åstadkomma i fråga om ett tidigare upptäckande och en förbättrad behandling af denna sjukdom. Jag har fått den upplysningen — och jag vill anföra det såsom ett litet faktiskt bidrag till hvad jag nu har sagt att erfarenheten vid sanatorierna gifva vid handen, att läkarevärlden i Sverige har följt med sin tid, att läkarne i tid skicka de sjuka till sanatorierna och att det är på detta sätt, som ett gynnsamt resultat vinnes. Under sådana förhållanden är det orättvist att säga, att det behöfver komma någon ny stimulus i läkarestudiet, för att läkarne skola lösa sin uppgift, såvidt det i ett visst tidsmoment är möjligt, på bästa sätt och med anlitande af de bästa källor, som finnas från forskningen öfver hela världen.

3. Carl Björck (Lantmannapartiet, man)

I likhet med den föregående talaren ber jag få nämna, att jag tror, att de svenska läkarne i de högskolor, där de utbildas, få ganska stor vana vid auskultering och perkussion och äfven vid de fysikaliska undersökningsmetoder, som användas be-

träffande upphostningar och sådant. Jag tror sålunda, att läkarne hafva en ganska god grundläggande kunskap för att i tid kunna diagnosticera tuberkulosen. Men jag är öfvertygad om att hvarje läkare, som skulle få att göra med dessa tuberkulosanstalter, gärna skulle vilja underkasta sig den självpröfningen, om han vore fullt kompetent att tidigt ställa diagnos på tuberkulos, ty det är därpå det hänger.

Nu har föreningen mot tuberkulos bildat stipendier för att läkarne skola begagna sig af

möjligheten att studera vid sanatorierna, och jag tror, att de äfven skola flitigt begagna sig däraf. Rätt många hafva redan till sin stora belåtenhet genomgått dessa kurser. Jag tror, i likhet med herr Juhlin, att staten kanske kunde lägga till några stipendier, så att det blefve flera, som kunde kowma att utbilda sig vid sanatorierna eller rättare sagdt där repetera och få reda på äfven de modernaste metoderna för tuberkulosens diagnos och behandling. Många läkare skulle helt säkert med glädje begagna sig däraf, ty det finnes kanske knappast något angenämare än att få arbeta på sin egen utveckling för att kunna hjälpa andra. En sådan där kurs tager 2 å 3 månader, och det är ju ganska öfvervinneligt. IHvarje svensk läkare kan, med de förkunskaper han har, med fördel begagna sig af dessa kurser.

Men detta blir en cura posterior, då vi få våra tuberkulossjukhus färdiga. Naturligtvis behötver det icke finnas en särskild läkare anställd vid hvarje tuberkulossjukstuga. Det skulle vara att fördyra saken och kanske göra den omöjlig. Man har i stället tänkt sig, att vid de mindre tuberkulossjukhusen, som hafva till uppgift att tidigt upptaga patienter och att isolera sådana, som tillhöra trångbodda familjer, hvarigenom de lätt kunna sprida smitta, på samma gång som de icke hafva någon vidare utsikt att så länge de äro kvar hemma vinna någon förbättring — man har tänkt sig, säger jag, att vid dessa anstalter någon läkare i närheten skulle kunna anställas för att hafva tillsyn och vård öfver dessa sjuka. Det är ju så, att icke behöfver en tuberkulös person hvarje dag undersökas af läkare, utan det är på vissa tider och med vissa mellanrum, som läkarne undersöka dessa patienter. Har man dessutom en skolad **s köterska**[3], så kan **hon**[2] anmäla för läkaren, när något kommer på — som det heter — och läkaren skulle då kunna göra sina iakttagelser och föreskrifter.

Jag tror, att Riksdagen får bereda sig på att, när denna fråga kommer i gång, anordna flera sädana där tuberkuloskurser för läkare, och jag tror icke, att detta behöfver blifva någon dyr eller svår sak. Jag tror icke heller, att de läkare, som få med dessa tuberkulossjukhus att göra, skola vara motvilliga att deltaga i dessa kurser. De, som hafva varit där, hafva på detta sätt utvidgat sina kunskaper, icke därför att de icke förut hade kunskaper i ämnet, utan därför att de ville vara tip-top i fråga om att på bästa sätt göra tidiga och skarpa diagnoser och leda behandlingen efter som hvarje sjuk behöfver.

I Danmark har man en anordning, som går ut på att hvarje läkare äger för undersökning till läkare vid tuberkulossjukhusen

sända upphostningar från sina patienter. Undersökningarna göras gratis, och detta bidrager till möjligheten att tidigt bestämma, om ett tuberkulostall föreligger. Något sådant skulle också i Sverige kunna komma till stånd.

Vi veta ju att Rom byggdes icke på en dag. Denna fråga är au, om jag så får säga, i sin födslostund, men säkert är att den kommer att gripa ganska långt omkring sig och kommer att ordnas på bästa sätt, ju längre tiden går framåt. Jag hoppas att kampen mot tuberkulosen skall blifva mer och mer segerrik och att man småningom skall få makt med denna sjukdom,

som bortrycker 10- å 12,000 personer hvartenda år. Bland personer af 20—40 års ålder utgöra ju dödsfallen i tuberkulos 53 procent. Således af den del at befolkningen, som skulle vara den raskaste och kraftigaste, bortryckes mer än hälften af denna sjukdom. Dessa siffror mana till kraftigt ingripande.

Men hvad nu läkarefrågan beträffar så tror jag ej, att man behöfver hafva bekymmer för att få dugliga läkarekrafter för att sköta de sjuka. Vi hafva redan sådana, och läkarne äro nog här i Sverige så ifriga att mer och mer utbilda sig att, om de få understöd af tuberkulosföreningen och af staten, de gärna gå igenom en kurs på ett par månader för att härvidlag fullkomna sig. Jag och många med mig glädja oss öfver, att Riksdagen så välvilligt upptagit denna sak och att frågan, efter hvad man har all anledning att hoppas, nu närmar sig sin lösning.